

1

消化器症状:薬剤師の実践ポイント

制吐薬の処方監査から服薬指導まで

1 服薬指導で伝えるポイント



制吐薬は「吐き気がしてから」ではなく、指示通り予防的に服用することを説明する



下痢時の水分・電解質補給の重要性と、市販の下痢止めを自己判断で使わないよう伝える



口内炎予防のための含嗽(うがい)のタイミングと方法を具体的に伝える

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ レジメンの催吐リスク分類に対して、制吐薬の種類・本数が不足していないか確認する
- ☐ NK1受容体拮抗薬使用時はCYP3A4を介した相互作用(デキサメタゾンの用量調整等)に注意する
- ☐ 高齢者・腎機能低下患者でのロペラミドの使用量・使用期間が適切か確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



制吐薬の効果不十分が続く場合は、次サイクルでのレジメン変更検討を処方医にフィードバックする



体重減少・経口摂取量を継続的に記録し、栄養指導が必要な場合は早めに連携する

4 実践チェックリスト

- ☐ 初回化学療法前に、制吐薬のスケジュール(いつ・何を服用するか)を患者さんと一緒に確認する
- ☐ 2サイクル目以降は、前回の症状の程度を必ず聴取し、制吐薬強化の要否を検討する
- ☐ 経口摂取不良が3日以上続く場合は、受診勧奨を優先する

「予防的に飲む」という制吐薬の基本を丁寧に説明できるかどうか、消化器症状マネジメントの成否を分ける。